HELP_Organi_P26 — Groupe F — Lots 247, 248, 217 à 226 — 19 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 26 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

F-075 — Haute — LOT 221 · SSP O6.8

Emplacement : evidence.json (LOT_221, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) ; LOT_219 LOT_219_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › LOT_221 not_found n° 1 ; LOT_217 not_found n° 4 ; LOT_219 not_found n° 4, uncertainties n° 12 et point XI.D (recherche 2026) ; LOT_220 uncertainties n° 11 ; LOT_222 not_found n° 3 ; LOT_226 uncertainties n° 1

Contexte : Les lots utilisent la recommandation SGAD/SGBP/SGPP 2016 (validité FMH jusqu'en 2024 ; 2020 sur Guidelines Schweiz) et le compte rendu ARS MEDICI 2024 d'une mise à jour 2024 « en préparation » (esketamine, rTMS, pharmacogénétique) ; la partie 2 (traitement d'entretien) n'est pas lue.

Question : La mise à jour suisse 2024 (ou plus récente) des recommandations SSAD/SGAD-SGBP-SGPP sur la dépression unipolaire est-elle publiée en texte intégral (parties 1 et 2 : titre, revue, année, URL), et quelles différences présente-t-elle par rapport à 2016 sur la gradation de la sévérité, le choix et la dose des antidépresseurs, la durée d'entretien, les benzodiazépines, l'esketamine et la rTMS ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-076 — Haute — LOT 221 · SSP O6.8

Emplacement : evidence.json (LOT_221, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) ; LOT_220 LOT_220_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › LOT_221 not_found n° 2 et uncertainties n° 4 ; LOT_220 not_found n° 7 et piège d'examen (220.4)

Contexte : LOT_220 a lu la version 2018 des directives ASSM « Attitude face à la fin de vie et à la mort » (5 conditions) ; LOT_221 a lu la révision 2022 en anglais (4 conditions, deux entretiens espacés de deux semaines) ; la version française 2022 n'est pas trouvée.

Question : Quel est le texte français en vigueur des directives ASSM « Attitude face à la fin de vie et à la mort » (révision 2022, chap. 6.2.1 : conditions de l'assistance au suicide, deux entretiens espacés d'au moins deux semaines, souffrance insupportable), avec URL, et comment le code de déontologie FMH l'intègre-t-il ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-077 — Haute — LOT 221 · SSP O6.8

Emplacement : evidence.json (LOT_221, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 4 (point 6 Cadre légal, psychothérapie)

Contexte : Seul l'effet du « modèle de la prescription » (Obsan 2024) est documenté ; l'OPAS art. 11b n'est pas lisible sur Fedlex.

Question : Que prévoit l'OPAS art. 11b en vigueur pour la psychothérapie pratiquée par des psychologues sur prescription médicale (médecins habilités, nombre de séances par prescription, bilan après 30 séances, intervention de crise) ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-081 — Haute — LOT 221 · SSP O6.8

Emplacement : evidence.json (LOT_221, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 11 et uncertainties n° 10 (trouble bipolaire, lithium)

Contexte : La recommandation suisse du trouble bipolaire de 2015 (SSTB) n'a été lue qu'en résumé ; Quilonorm® retard 450 mg par comprimé est déduit de « 4 comprimés (1800 mg) ».

Question : Existe-t-il une recommandation suisse du trouble bipolaire postérieure à 2015, et que prévoit l'IP suisse de Quilonorm® retard (dosage par comprimé, dose initiale, lithiémie cible, adaptation rénale, surveillance) ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-082 — Haute — LOT 221 · SSP O6.8

Emplacement : evidence.json (LOT_221, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) ; LOT_222 evidence.json (LOT_222, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › LOT_221 not_found n° 12 ; LOT_222 uncertainties n° 6

Contexte : LOT_221 : grammes d'alcool par verre standard et période de référence des seuils OFSP (2/4 verres) non précisés. LOT_222 : conflit OFSP (≥ 2 verres F, ≥ 4 verres H) / HUG 2017 (> 20 g F, > 30 g H) arbitré pour l'OFSP.

Question : Quels repères de consommation à faible risque et quels seuils de consommation chronique à risque et ponctuelle excessive publie la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions (CFANT/OFSP) en vigueur, et combien de grammes d'alcool pur contient un verre standard en Suisse ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-078 — Moyenne — LOT 221 · SSP O6.8

Emplacement : evidence.json (LOT_221, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 5, 8 et uncertainties n° 5 (point 3 Épidémiologie)

Contexte : Prévalences suisses du trouble bipolaire, du TSPT, du trouble de l'adaptation, de la dépression du post-partum et de la détresse spirituelle hors gériatrie non trouvées ; détresse psychologique MHI-5 (ESS 2022 : 15 % → 18 %) non vérifiée sur la source primaire.

Question : Quelles prévalences suisses publient l'Obsan ou l'OFS (ESS 2022) pour la détresse psychologique MHI-5 (moyenne et élevée), le trouble bipolaire, le TSPT et la dépression du post-partum ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-079 — Moyenne — LOT 221 · SSP O6.8

Emplacement : evidence.json (LOT_221, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 7 (dépistage de l'hypomanie)

Contexte : Les seuils et la Se/Sp de l'HCL-32 (Angst) ne figurent pas dans les résumés lus.

Question : Quel seuil de l'HCL-32 et quelles sensibilité et spécificité (validation de Angst et versions françaises ou allemandes) sont recommandés pour dépister la bipolarité devant une dépression ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-080 — Moyenne — LOT 221 · SSP O6.8

Emplacement : evidence.json (LOT_221, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 9 (point 11.D recherche, dépression du post-partum)

Contexte : Le statut suisse de la brexanolone et de la zuranolone n'a pas été trouvé.

Question : La brexanolone ou la zuranolone (Zurzuvae®) sont-elles autorisées par Swissmedic ou l'EMA en 2026 pour la dépression du post-partum, avec quelle posologie ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-083 — Moyenne — LOT 221 · SSP O6.8

Emplacement : evidence.json (LOT_221, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › uncertainties n° 2 (TAG, critère de durée)

Contexte : Le dossier signale une divergence : durée ≥ 6 mois (ligne directrice suisse 2024) contre « au moins plusieurs mois » (CIM-11).

Question : Quel critère de durée du trouble anxieux généralisé retiennent la recommandation suisse 2024 sur les troubles anxieux (titre, URL) et les CDDR CIM-11, et quelles doses de première ligne (ISRS, IRSN, prégabaline) recommande-t-elle ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-084 — Haute — LOT 222 · SSP O6.9

Emplacement : evidence.json (LOT_222, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) ; LOT_224 LOT_224_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › LOT_222 not_found n° 2 et uncertainties n° 5 ; LOT_224 not_found n° 1 et uncertainties n° 2

Contexte : Les deux lots connaissent Hochstrasser et al., « Le traitement du burnout », Forum Med Suisse 2016 (parties 1 et 2), seulement par des diapositives HUG 2018 : gradation de l'arrêt dans l'épisode dépressif (léger : pas d'arrêt ; moyen : cas par cas ; sévère : arrêt), part de dépression dans le burnout (20 %/60 %), benzodiazépine « à demi-vie longue » sans posologie.

Question : Quelle conduite (stades du burnout, arrêt de travail total ou partiel et sa durée, psychothérapie, antidépresseurs, reprise progressive) recommande le consensus suisse sur le burnout de Hochstrasser et al. (Forum Med Suisse 2016) ou sa mise à jour, et existe-t-il une version plus récente ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-086 — Haute — LOT 222 · SSP O6.9

Emplacement : evidence.json (LOT_222, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 5 et uncertainties n° 9 (DX fatigue, carence martiale)

Contexte : Seul le seuil de ferritine de 70 µg/L en cas d'inflammation (OMS) est vérifié ; le seuil < 15 µg/L chez l'adulte sain n'est pas lu ; Vaucher 2012 utilise 50 µg/L comme critère d'essai.

Question : Quels seuils de ferritine définissent la carence martiale chez l'adulte sain, en cas d'inflammation et dans la fatigue isolée selon la ligne directrice OMS 2020 et une recommandation suisse (SSMIG, smarter medicine, Swiss Medical Forum), et quel traitement oral ou IV (IP suisse) est recommandé ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-088 — Haute — LOT 222 · SSP O6.9

Emplacement : evidence.json (LOT_222, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) ; LOT_224 LOT_224_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › LOT_222 not_found n° 7 ; LOT_224 not_found n° 10

Contexte : LOT_222 : prévalence suisse du SAOS symptomatique, critères de somnolence (Epworth) et recommandations sur le SAOS et la conduite non lus. LOT_224 : recommandations SSRS (somnolence et conduite) et règles des postes de sécurité non lues.

Question : Quelles recommandations suisses (Société suisse de recherche sur le sommeil, Société suisse de médecine du trafic, OAC annexe 1 exigences médicales minimales) fixent l'aptitude à la conduite en cas de SAOS ou de somnolence (seuil d'Epworth, délai après traitement par PPC, groupes 1 et 2), et quelle est la prévalence suisse du SAOS (HypnoLaus) ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-085 — Moyenne — LOT 222 · SSP O6.9

Emplacement : evidence.json (LOT_222, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) ; LOT_224 LOT_224_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › LOT_222 not_found n° 1 ; LOT_224 not_found n° 11

Contexte : Le Job-Stress-Index 2022/2024 de Promotion Santé Suisse n'est pas accessible (CAPTCHA) ; les chiffres de presse (30,3 % épuisés, 6,5 milliards CHF) ne sont pas retenus.

Question : Quels résultats publie le Job-Stress-Index 2024 (ou plus récent) de Promotion Santé Suisse (part des actifs épuisés, potentiel économique, URL du rapport) ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-087 — Moyenne — LOT 222 · SSP O6.9

Emplacement : evidence.json (LOT_222, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) ; LOT_226 evidence.json (LOT_226, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › LOT_222 not_found n° 6 ; LOT_226 not_found n° 13

Contexte : LOT_222 : forfait CSIAS pour l'entretien 2026 connu seulement par le synopsis de révision. LOT_226 : rente minimale AVS 2026 (base de l'allocation pour impotent) non lue.

Question : Quels montants sont en vigueur en 2026 pour le forfait CSIAS pour l'entretien (ménage d'une personne et barème), la rente minimale et maximale AVS/AI et l'allocation pour impotent (degrés faible, moyen, grave) ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts,

état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-089 — Moyenne — LOT 222 · SSP O6.9

Emplacement : evidence.json (LOT_222, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 8 (point 6, burnout et assurance-accidents)

Contexte : Aucune statistique ni jurisprudence n'a été lue sur la reconnaissance du burnout comme maladie professionnelle LAA.

Question : Le burnout ou un trouble psychique lié au travail peut-il être reconnu comme maladie professionnelle au sens de la LAA art. 9 al. 2 (jurisprudence du Tribunal fédéral, position de la Suva) ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-090 — Moyenne — LOT 222 · SSP O6.9

Emplacement : evidence.json (LOT_222, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 12 (point 11.B, remboursement)

Contexte : L'autorisation des 12 spécialités citées est vérifiée via AmiKo ; leur remboursement (Liste des spécialités ePL OFSP) n'est pas vérifié.

Question : Les 12 spécialités citées dans le dossier LOT_222 (antidépresseurs, Campral®, Seresta®, fer) figurent-elles dans la Liste des spécialités en vigueur, avec quelles limitations ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-092 — Haute — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « IP suisse Ciproxine® puis revue sur l'azithromycine » ; fenêtre Ceftriaxone ; lacunes (223.22) ; evidence not_found n° 5, 6 et uncertainties n° 13, 14

Contexte : Le cours cite Ciproxine® 2 × 500 mg 1 jour (diarrhée grave) et une indication « Typhus » de 7 jours, vraisemblablement la fièvre typhoïde ; azithromycine hors étiquette ; résistance de S. Typhi aux quinolones (90 % en Angleterre) ; Rocephin® 1–2 g/j, durée « non trouvée ».

Question : Quelles doses et durées d'azithromycine (adulte, enfant) pour l'autotraitement de la diarrhée du voyageur et pour la fièvre entérique recommandent le CEMV/OFSP ou une source européenne récente, l'IP allemande de Ciproxine® vise-t-elle la fièvre typhoïde par « Typhus », et quelle durée de ceftriaxone est recommandée dans la fièvre entérique ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-093 — Haute — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Tableau DX.10 (dermatoses), lacunes (223.23) ; evidence not_found n° 7

Contexte : Le cours cite albendazole ou ivermectine (hors étiquette) dans la larva migrans cutanée ; posologie « donnée non trouvée ».

Question : Quelles posologies d'ivermectine (Subvectin® ou autre) et d'albendazole recommandent une source européenne ou le Swiss TPH pour la larva migrans cutanée, chez l'adulte et l'enfant ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-095 — Haute — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « RSI annexe 7 » ; lacunes (223.26) ; evidence not_found n° 10 et uncertainties n° 1, 11

Contexte : Le cours cite l'IP Stamaril® et le RSI (dose unique valable à vie), le CEMV (rappel unique ≥ 10 ans, max. 2 doses) et le Bulletin OFSP 36/2025 ; allaitement : CEMV < 6 mois contre plan de vaccination 2026 (6 à 9 mois) ; procédure d'exemption « donnée non trouvée ».

Question : Quelles indications de rappel antiamaril (immunocompétent, enfant vacciné < 2 ans, grossesse, VIH), quelle conduite pendant l'allaitement et quelle procédure d'exemption (certificat de contre-indication, modèle OMS) fixent le CEMV et le plan de vaccination suisse 2026 ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses

éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P26 — 19 questions : F-075, F-076, F-077, F-081, F-082, F-078, F-079, F-080, F-083, F-084, F-086, F-088, F-085, F-087, F-089, F-090, F-092, F-093, F-095